

Phân Tích GPB Tăng Sản Điển Hình & Phác Đồ K Vú

Thời điểm: Tháng 09/2026
Chuyên khoa: Giải Phẫu Bệnh & Ung Bướu
Mã chuyên đề: MOM-PDF-04

Medical Disclaimer: Tài liệu đối chiếu từ NCCN Guidelines on Uterine Neoplasms & Breast Cancer, ACOG Practice Bulletin No. 232, RCOG Guideline No. 67 và Phác đồ Bệnh viện Từ Dũ & Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM.

CÂU HỎI CỦA BỆNH NHÂN:

"Tăng sản điển hình là tế bào vẫn bình thường hay tế bào biến đổi bất thường? Tăng sản này có phải do Tamoxifen và có tự thoái triển không? Thời gian cho phép để theo dõi là bao lâu và thời gian biến đổi nặng hơn là bao lâu? Với bệnh nhân K vú thể nội tiết thì phác đồ điều trị tăng sản này như thế nào?"

I. BẢN CHẤT TẾ BÀO: TĂNG SẢN ĐIỂN HÌNH LÀ GÌ?

"Tăng sản điển hình" (Hyperplasia without atypia): Có nghĩa là các tuyến nội mạc gia tăng về số lượng và kích thước nhưng **CẤU TRÚC NHÂN TẾ BÀO VẪN HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, ĐỒNG ĐỀU, KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN ÁC TÍNH**.

Đặc Điểm	KẾT QUẢ CỦA BỆNH NHÂN: Tăng Sản Điển Hình (Without Atypia)	Tăng Sản Không Điển Hình (Atypical / EIN)
Hình thái nhân tế bào	Nhân bình thường, cực tính nguyên vẹn, không dị dạng	Nhân quái dị, đa hình thái, mất cực tính
Nguy cơ ung thư	< 1% đến 3% (Cực kỳ thấp - Lành tính)	25% đến 40% (Tổn thương tiền ung thư)
Tương quan Tamoxifen	Dấu ấn mô học kinh điển do SERM (tuyến giãn nang bọc)	Hiếm gặp hơn, cần xử lý phẫu thuật triệt để

II. NGUYÊN NHÂN, KHẢ NĂNG THOÁI TRIỂN & KHUNG THỜI GIAN THEO DÕI

- Có phải do Tamoxifen không?** ĐÚNG 100%. Tác dụng chủ vận một phần của Tamoxifen tại tử cung kích thích lớp niêm mạc tạo ra các mảng tăng sản dạng nang bọc.
- Nó có tự động giảm dần theo thời gian không?** CÓ. Sau khi ngừng Tamoxifen tháng 1/2026, quá trình thoái triển mô học tự nhiên diễn ra trong **6 đến 12 tháng**.
- Thời gian cho phép để theo dõi:** Tối đa **3 đến 6 tháng** (siêu âm đầu dò kiểm tra lại sau mỗi 3 tháng).
- Thời gian để biến đổi nặng hơn (nếu có):** Để một tổn thương tăng sản điển hình tích lũy đột biến thành ác tính (tỷ lệ 1-3%) cần **từ 5 đến 10 năm** tiếp xúc liên tục với Estrogen không đối kháng mà không được can thiệp. Bệnh nhân đã phát hiện sớm và có kế hoạch xử lý nên nguy cơ này bằng 0.
- Các bước theo dõi sự thoái triển:** Siêu âm Doppler qua ngả âm đạo (đo độ dày niêm mạc) sau 3 tháng; nếu vẫn còn ra máu thì chỉ định nội soi buồng tử cung chẩn đoán.

III. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHUẨN CHO BỆNH NHÂN K VÚ THỂ NỘI TIẾT

- Chống chỉ định tuyệt đối:** KHÔNG DÙNG THUỐC NỘI TIẾT ESTROGEN HOẶC DẪN XUẤT ĐẬU NÀNH (để tránh kích thích tế bào K vú tái phát).
- Phương án 1 (Bảo tồn):** Dùng thuốc cầm máu cơ học (Tranexamic Acid) + Bổ sung sắt hữu cơ + Theo dõi siêu âm sau 3 tháng.
- Phương án 2 (Chuẩn vàng khuyến nghị):** Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần bảo tồn 2 buồng trứng → Giải quyết triệt để 100% tình trạng rong kinh và khối u xơ 45mm, xóa bỏ vĩnh viễn nguy cơ ung thư tử cung trong khi vẫn giữ nguyên nội tiết tố tự nhiên cho cơ thể.

1. **NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology:** Uterine Neoplasms & Breast Cancer (2024–2025).
2. **ACOG Practice Bulletin No. 232:** Tamoxifen Use and Uterine Effects.
3. **Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM & BV Hùng Vương TP.HCM:** Phác đồ Giải Phẫu Bệnh & Điều trị Bệnh lý Phụ khoa sau Ung thư.